Plan de Demo Sistema Médico - Sprint 3

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Fecha y Hora: _____

Participantes de la reunión de Demo: _____

Modalidad: Demo virtual

Alcance de la demo

Se muestran las 20 User Stories planificadas para Sprint 3 y, en un apartado separado, las US-13 y US-16 incorporadas como carry-on del Sprint 2 e implementadas durante Sprint 3. Los escenarios agrupan historias relacionadas para recorrer los flujos funcionales completos.

Lista de USs del Sprint 3

US-63 - Agenda del vacunatorio
US-33 - Definición del costo de la consulta por el médico
US-32 - Gestión de la cobertura médica
US-39 - Ficha de diagnóstico del paciente
US-45 - Reporte de turnos por especialidad
US-48 - Reporte de asistencia de pacientes
US-30 - Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada
US-28 - Turno de vacunación
US-34 - Cálculo del importe según cobertura
US-22 - Aviso por modificación de agenda
US-40 - Consulta de la ficha del paciente
US-41 - Historial clínico del paciente
US-62 - Adjuntar estudios a la ficha
US-29 - Registro de aplicación de dosis
US-17 - Gestión de turnos desde mostrador
US-35 - Registro del pago en efectivo o por transferencia
US-44 - Auditoría de accesos al historial
US-57 - Carnet de vacunación del paciente
US-36 - Comprobante de pago en PDF
US-47 - Reporte de pagos realizados

Carry-on del Sprint 2 - implementadas en Sprint 3

US-13 - Reserva de turno con control de concurrencia

US-16 - Cancelación de turno por el paciente

001 - Agenda y reserva de vacunación (US-63, US-28)

Escenario 1 - Camino exitoso

1 - Con rol Enfermera, cargar disponibilidad futura del vacunatorio y confirmar la agenda. Verificar que se publica automáticamente en turnos de 30 minutos y no aplica la regla de 2 a 7 jornadas médicas.

2 - Ingresar con la segunda cuenta de Enfermería y comprobar que ambas ven y administran la misma agenda, independiente de las agendas médicas.

3 - Como paciente o desde mostrador, elegir una vacuna activa, filtrar por rango de fechas y seleccionar un horario disponible.

4 - Reservar para sí y, en otra pasada, a nombre de otra persona con sus datos y cobertura. Comprobar que puede coincidir con un turno médico de la persona y que la confirmación llega por email a quien reservó.

5 - Verificar que la reserva no solicita ni descuenta stock de vacunas.

Resultado esperado:
La agenda del vacunatorio publica turnos propios de 30 minutos; las dos enfermeras la comparten y el turno queda asociado a la vacuna y persona atendida, incluso si es un tercero o coincide con un turno médico.

Escenario 2 - Rango sin disponibilidad

1 - Buscar en un rango sin turnos disponibles e intentar confirmar sin seleccionar un horario.

Resultado esperado:
El sistema informa que no hay turnos para el rango y no crea una reserva incompleta ni impone validaciones de stock o de jornadas médicas.

002 - Aplicación de dosis y carnet (US-29, US-57)

Escenario 1 - Camino exitoso

1 - Con una enfermera autenticada, abrir un turno de vacunación reservado y registrar vacuna, dosis del esquema, fecha y hora de aplicación.

2 - Guardar y comprobar que la enfermera responsable se toma de la sesión, el registro se vincula al turno y no se solicita lote ni se modifica stock.

3 - Como paciente, consultar el carnet: revisar vacuna, dosis, fecha y completitud del esquema; descargarlo en PDF.

Resultado esperado:
La aplicación queda trazable, vinculada al turno cuando corresponde y visible en el carnet descargable. El carnet incluye solo aplicaciones registradas en la sala.

Escenario 2 - Corrección y esquema incompleto

1 - Usar una vacuna cuyo esquema requiera más dosis que las aplicadas y comprobar el aviso de esquema incompleto.

2 - Intentar eliminar una aplicación guardada; en su lugar, anularla indicando el motivo y volver a revisar el carnet.

Resultado esperado:
El esquema incompleto se identifica; la aplicación original no se borra y su corrección queda registrada mediante anulación con motivo.

003 - Cobertura, precio, cobro y comprobante (US-32 a US-36)

Escenario 1 - Camino exitoso con cobertura

1 - Como administrador, revisar una entidad y su descuento configurado. Como paciente o administrativo, consultar o corregir la cobertura de la persona atendida (entidad, plan y número de afiliado) y verificar autor y fecha del cambio.

2 - Como médico, definir el precio único sin cobertura para su consulta con fecha de vigencia; consultar el historial y comprobar que corresponde solo a su perfil.

3 - Usar una consulta cumplida, incluida una reservada para otra persona. Mostrar el desglose con el precio vigente a la fecha de atención, el descuento de la cobertura de la persona atendida y el importe final.

4 - Registrar un pago en efectivo como administrativo. En otra consulta, registrar transferencia asentando la referencia del comprobante presentado. Verificar turno, fecha, hora, importe, medio y usuario; confirmar que no se procesa un pago en línea.

5 - Abrir el PDF generado automáticamente y validar numeración correlativa y datos de sala, paciente, prestación, profesional, importe y medio. Descargarlo desde las cuentas permitidas: paciente, reservante y administrativo.

Resultado esperado:
El importe usa la cobertura de la persona atendida y el precio vigente de su médico; el pago presencial queda registrado una sola vez por turno y genera un comprobante interno descargable, con numeración sin duplicados ni huecos.

Escenario 2 - Particular, precio faltante y duplicado

1 - Calcular el importe para un paciente particular y verificar que no hay descuento. Cambiar la cobertura después de un pago y comprobar que el pago histórico conserva los valores originales.

2 - Intentar cerrar el cobro de una consulta cuyo médico no tiene precio configurado; luego intentar registrar un segundo pago activo para un turno ya cobrado y descargar un comprobante desde una cuenta no autorizada.

Resultado esperado:
El particular paga el precio sin cobertura; sin precio configurado no se cierra el cobro; no se admiten pagos activos duplicados ni descargas fuera de los roles habilitados.

004 - Ficha médica, consulta consolidada y estudios (US-39, US-40, US-62)

Escenario 1 - Camino exitoso

1 - Como médico, abrir un turno cumplido y cargar diagnóstico, tratamiento y observaciones. Verificar la firma con profesional, fecha y hora del usuario autenticado y la fecha y hora de última edición.

2 - Agregar otra consulta del mismo paciente con el mismo profesional y comprobar que se añade a la ficha única paciente-médico. Adjuntar una imagen o PDF dentro del máximo configurado y confirmar que queda vinculado a la entrada.

3 - Desde el acceso directo, abrir la vista consolidada: buscar por documento o apellido y filtrar por profesional, especialidad o fechas; revisar fichas, autor, especialidad y orden cronológico inverso.

4 - Descargar el adjunto como paciente y revisar que el acceso queda en auditoría.

Resultado esperado:
La carga crea o amplía la ficha única; la vista consolidada incluye las fichas de todos los médicos y es de solo lectura; los adjuntos permitidos quedan vinculados, descargables y auditados.

Escenario 2 - Permisos y entrada fuera de fecha

1 - Intentar cargar sobre un turno no cumplido y hacerlo con un rol que no sea Médico. Intentar que otro médico edite una entrada ajena y que el autor modifique una entrada de un día anterior.

2 - Intentar adjuntar un formato no permitido y un archivo que supere el máximo configurado.

Resultado esperado:
Solo un médico carga sobre un turno cumplido; entradas ajenas o vencidas no se editan (las correcciones posteriores se agregan como nuevas entradas) y adjuntos inválidos o excedidos se rechazan.

005 - Historial del paciente y auditoría (US-41, US-44)

Escenario 1 - Consulta autorizada

1 - Como paciente, abrir el historial propio. Revisar las entradas de todas las fichas en modo de solo lectura, con el texto clínico visible y sin notas internas; descargar el historial en PDF.

2 - Como administrador, abrir el log y filtrar por usuario, paciente y rango de fechas; localizar el acceso exitoso y verificar usuario, paciente, fecha, hora y tipo de acceso.

Resultado esperado:
El paciente consulta y descarga solo su información, sin editarla; el administrador accede al log de solo lectura y encuentra el acceso registrado.

Escenario 2 - Acceso rechazado

1 - Como paciente, intentar abrir el historial de otra persona; luego intentar consultar el log como un rol que no sea Administrador.

2 - Volver al log con rol Administrador y localizar el intento rechazado al historial.

Resultado esperado:
El acceso a datos ajenos se rechaza y el intento queda auditado; el log de historial es de solo lectura y exclusivo del Administrador.

006 - Bloqueo de agenda y aviso al paciente (US-30, US-22)

Escenario 1 - Bloqueo con reservas afectadas

1 - Como médico, seleccionar un rango futuro de fechas y horas e indicar el motivo. Repetir desde el mostrador como administrativo.

2 - Revisar el conteo previo a confirmar: identificar turnos libres y reservados, que se listan aparte. Confirmar y comprobar que solo los libres dejan de ofrecerse.

3 - Comprobar el email a cada paciente afectado, con turno y forma de reprogramarlo, y el listado que recibe el administrativo para contactarlos.

Resultado esperado:
El sistema advierte cuántas reservas hay; bloquea solo horarios libres, no cambia ni cancela turnos reservados, notifica a los pacientes y deja la gestión de cancelación al mostrador.

Escenario 2 - Sin reservas y reversión

1 - Bloquear una franja sin turnos reservados y revisar que no se envían avisos innecesarios. Revertir el bloqueo mientras sus fechas sean futuras; intentar revertir un bloqueo cuya fecha ya pasó.

Resultado esperado:
El bloqueo es reversible antes de las fechas afectadas; no se ofrecen horarios bloqueados y no se modifica una agenda pasada.

007 - Gestión de turnos desde el mostrador (US-17)

Escenario 1 - Camino exitoso

1 - Como administrativo, buscar un paciente por documento, apellido o email. Repetir con un paciente nuevo y completar sus datos y cobertura desde el alta integrada.

2 - Reservar desde mostrador un turno médico y uno de vacunación. Reprogramar uno como cancelación del original más reserva de un horario nuevo, sin editar el turno reservado.

3 - En un turno ya ocurrido, marcar cumplido y en otro ausente. Abrir el cálculo del importe y registro de pago desde el turno cumplido. Verificar emails y el usuario responsable de cada acción.

Resultado esperado:
El mostrador gestiona ambos tipos de turno; el alta puede completarse en el flujo, la reprogramación se resuelve en una operación sin editar una reserva y cada acción queda registrada y notificada.

Escenario 2 - Límites de operación

1 - Intentar cambiar el estado de un turno futuro y buscar un paciente inexistente sin completar el alta. Intentar reprogramar editando directamente fecha o profesional del turno reservado.

Resultado esperado:
No se cambia el estado antes del día del turno ni se edita una reserva; el alta, reserva o reprogramación solo se confirma al completar los datos y la operación correspondiente.

008 - Reportes administrativos (US-45, US-47, US-48)

Escenario 1 - Reportes con datos

1 - Como administrador, elegir un período en el reporte de turnos y revisar totales de turnos, cumplidos, ausentes y cancelados por especialidad, desglose por profesional, gráfico y exportación PDF/CSV.

2 - En pagos, filtrar por período, efectivo o transferencia y cobertura; verificar particular vs. cobertura y desglose por especialidad/profesional. Confirmar que un pago anulado aparece identificado pero no suma (usar un registro de prueba ya anulado).

3 - En ausentismo, revisar el porcentaje sobre turnos reservados y desglosar por profesional, especialidad, tipo de turno y día de semana; identificar pacientes con más ausencias y excluir cancelaciones realizadas por la sala.

4 - Exportar los reportes a PDF y CSV con los filtros seleccionados.

Resultado esperado:
Los reportes aplican período y filtros, presentan los totales y desgloses solicitados y permiten exportar en ambos formatos; pagos anulados y cancelaciones de sala se tratan según las reglas del reporte.

Escenario 2 - Período sin datos

1 - Consultar un rango sin registros y un período sin turnos reservados; intentar filtros que no tengan resultados.

Resultado esperado:
El sistema informa que no hay datos y no presenta totales engañosos ni divide por cero al calcular el ausentismo.

009 - Carry-on del Sprint 2: reserva y cancelación (US-13, US-16)

Escenario 1 - Reserva y cancelación exitosas

1 - Como paciente, buscar un horario futuro, revisar el resumen con profesional, especialidad, fecha y hora, agregar opcionalmente un motivo y confirmar. Verificar que aparece en el listado a nombre de quien será atendido y desaparece de la búsqueda.

2 - Mantener dos sesiones con el mismo horario y confirmar desde ambas: completar una reserva y luego confirmar la segunda. Revisar que la segunda recibe el aviso de no disponibilidad y vuelve a resultados actualizados.

3 - Cancelar desde el listado un turno propio y otro reservado para un tercero, confirmando antes de ejecutar. Confirmar que el turno vuelve a estar disponible, llegan avisos al usuario y a la sala, y queda en el historial sin borrarse.

Resultado esperado:
La reserva se confirma de forma atómica (solo una sesión gana); un turno reservado no se edita. La cancelación permitida libera el horario, notifica a las partes y conserva trazabilidad.

Escenario 2 - Bordes de fecha y plazo

1 - Intentar reservar un horario pasado y cancelar un turno que comienza en menos de 24 horas. Intentar modificar una reserva confirmada sin cancelarla.

Resultado esperado:
No se reservan turnos pasados; la cancelación fuera del plazo mínimo se bloquea con explicación y una reserva confirmada no se modifica directamente.